



- SIMULADO NACIONAL - enamed

Exame Nacional de Avaliação
da Formação Médica

2025

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES

- O Simulado Nacional ENAMED 2025, 100% on-line, é composto por 50 questões de múltipla;
- Apenas as questões objetivas irão contar para a pontuação no ranking;
- A prova poderá ser baixada no [Portal do Estratégia MED](#). Se preferir, você pode baixá-la e imprimi-la;
- A prova terá duração máxima de 2 horas e 30 minutos. Os candidatos terão das 14h às 16h30min (horário de Brasília) para responder às questões e para enviar o gabarito preenchido por meio do formulário eletrônico disponível no link constante neste caderno de questões ou, também, no [Portal do Estratégia MED](#);
- O formulário ficará disponível para preenchimento durante toda aplicação da prova (14h às 16h30);
- O Estratégia MED divulgará o gabarito preliminar em seu portal a partir das 17h do dia 18 de maio de 2025;
- É de inteira responsabilidade do candidato a verificação prévia da integridade e conectividade de seus equipamentos eletrônicos;
- O candidato deverá usar no preenchimento do gabarito o mesmo e-mail que será utilizado no cadastro da plataforma;
- A premiação será a chance de concorrer a 01 Kit Exclusivo do Estratégia MED para o primeiro colocado, desde que o endereço de entrega esteja localizado no Brasil.
- Para fins de desempate, será considerado o menor horário de envio do gabarito.



PREENCHA SEU GABARITO



 Estratégia MED

 @estrategiamed

 @estrategiamed

 t.me/estrategiamed

 /estrategiamed

CLÍNICA MÉDICA

1. (Estratégia MED 2025 – Prof. Bruno Ferraz) Um paciente de 74 anos, com história de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, procura o pronto-socorro após início súbito de palpitações há 3 horas. Encontra-se hemodinamicamente estável, sem dor torácica, dispneia ou síncope. Ao exame físico, apresenta-se taquicárdico (frequência de 158 bpm), pressão arterial de 134 x 82 mmHg, ausculta cardíaca com ritmo irregular e sem sopros, e ausculta pulmonar sem estertores. O eletrocardiograma mostra ritmo irregular com QRS estreito, ausência de ondas P visíveis e resposta ventricular rápida. Qual é a conduta inicial mais adequada?

- A) Cardioversão elétrica sincronizada com 100J.
- B) Administração de betabloqueador venoso e anticoagulação plena.
- C) Infusão de amiodarona venosa para reversão do ritmo.
- D) Tentativa de manobra vagal e administração subsequente de adenosina.
- E) Administração de digital endovenoso apenas.

2. (Estratégia MED 2025 – Profª. Isabella Parente) Relacione as doenças da Coluna 1 com as características clínicas correspondentes da Coluna 2, preenchendo os parênteses.

Escolha a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

Coluna 1 – Doenças:

- 1. Doença Celíaca.
- 2. Síndrome do Intestino Irritável.
- 3. Doença de Crohn.
- 4. Intolerância à Lactose.

Coluna 2 – Características:

- () Presença de anticorpos antitransglutaminase e atrofia de vilosidades intestinais.
- () Pode cursar com lesões transmuralis, fístulas e acometimento de todo o trato gastrointestinal.
- () Diarreia e distensão abdominal após ingestão de queijos e derivados de leite.
- () Diarreia recorrente associada à dor abdominal que melhora com a evacuação, sem alterações estruturais intestinais.

- A) 1-3-4-2
- B) 3-1-4-2
- C) 1-3-2-4
- D) 1-4-3-2
- E) 3-1-4-2

3. (Estratégia MED 2025 – Prof. Rodrigo Frezatti) Um paciente com 58 anos de idade, com dez anos de escolaridade, apresenta há cerca de 12 meses alterações comportamentais caracterizadas por labilidade do humor, episódios de agressividade, irritação e comportamentos “bizarros”. Segundo a filha, há cerca de 1 semana, em uma festa de família, o paciente retirou toda a roupa e urinou em público. Os familiares mostram grande preocupação com o quadro, enquanto o paciente nega quaisquer sintomas. Contudo, desde que passou a apresentar tais sintomas, não cuida mais de afazeres do dia a dia como pagamento de contas, fazer compras do dia a dia ou mesmo dirigir sozinho. No MiniExame do Estado Mental (MiniMental), obteve 30/30 pontos. Os exames laboratoriais da paciente: hemograma, funções renal, hepática e tireoidiana, dosagem de sódio e de vitamina B12 apresentaram-se todos sem alterações. O resultado das sorologias para HIV, hepatites B e C e teste treponêmico foram negativos. Considerando-se esse caso, assinale a alternativa correta.

- A) A normalidade do exame de minimental afasta o diagnóstico de demência.
- B) O exame de LCR é imprescindível na investigação do quadro.
- C) O diagnóstico mais provável é de demência por corpúsculos de Lewy.
- D) A afasia primária progressiva pode ser um subfenótipo dessa condição.
- E) O diagnóstico de demência vascular é o mais provável.

4. (Estratégia MED 2025 – Profª. Fernanda Bidiani) Paciente em tratamento de neoplasia de pulmão do tipo pequenas células dá entrada no pronto atendimento com quadro de crise convulsiva. Realizou tomografia de crânio, sem alterações. Ao exame, apresenta-se afebril, normotensa, normocárdica, boa perfusão periférica, extremidades sem edemas. Coletados exames laboratoriais que identificaram: Creatinina 0,9mg/dL – Ureia 27mg/dL – Sódio 119mEq/L – Potássio 3,8mEq/L – Glicemia 112mg/dL – Osmolaridade sérica 264mOsm/L – Osmolaridade urinária 350mOsm/L.

Qual o tratamento indicado para o manejo da hiponatremia?

- A) Infusão da solução NaCl 3% 1mL/kg/h e reavaliar sódio de 6/6h.
- B) Infusão da solução NaCl 3% em bolus 150mL até 2 vezes, com 20-30 minutos de intervalo, até melhora dos sintomas ou elevação 4-6mEq/L.
- C) Infusão da solução NaCl 3% 1mL/kg/h até melhora dos sintomas e manter infusão da solução 0,5mL/kg/h por mais 24h.
- D) Infusão da solução NaCl 3% em bolus 50mL até 30/30 minutos, e reavaliar sódio de 2/2h.
- E) Infusão da solução NaCl 3% em bolus 200mL em 30 minutos, e manter infusão da solução 0,5mL/kg/h por mais 24h.

5. (Estratégia MED 2025 – Prof. Juan Demolinari) Homem de 36 anos, previamente hígido, procura atendimento médico após episódio de dor torácica ventilatório-dependente e dispneia de início súbito. Relata que há cerca de 2 dias fez um voo internacional de longa duração. Ao exame físico, apresenta-se eupneico em repouso, frequência respiratória de 22 irpm, frequência cardíaca de 105 bpm, pressão arterial de 128 × 78 mmHg, saturação de O₂ de 94% em ar ambiente. Ausculta pulmonar revela murmúrio vesicular diminuído em base pulmonar direita, sem estertores ou sibilos. O exame complementar solicitado mostra gasometria arterial com PaO₂ = 68 mmHg, pH = 7,44, PaCO₂ = 32 mmHg, HCO₃⁻ = 22 mmol/L. O eletrocardiograma evidencia taquicardia sinusal e padrão S1Q3T3. A angiotomografia pulmonar confirma a presença de tromboembolismo pulmonar em ramo segmentar direito, sem sinais de disfunção ventricular direita. O ecocardiograma é normal.

Com base nesse caso, a conduta inicial mais adequada é:

- A) Anticoagulação com heparina não fracionada e trombólise sistêmica imediata.
- B) Anticoagulação com heparina de baixo peso molecular e observação hospitalar.
- C) Alta hospitalar com prescrição apenas de analgesia e reavaliação ambulatorial em 7 dias.
- D) Iniciar anticoagulação oral imediata com varfarina.
- E) Inserção de filtro de veia cava inferior e anticoagulação oral.

6. (Estratégia MED 2025 – Profª. Larissa Costa) Paciente de 32 anos, G2P1, com 8 semanas de gestação, sem comorbidades prévias, realiza exames de pré-natal. Apresenta TSH de 3,1 mUI/L e anticorpos anti-TPO positivos. Paciente nega queixas. Assinale a alternativa correta quanto ao manejo do caso:

- A) Não tratar, pois o TSH está abaixo de 4,0 mUI/L e a paciente não apresenta sintomas.
- B) Iniciar levotiroxina na dose de 1mcg/kg/dia.
- C) Não tratar. A dosagem rotineira de TSH não deve fazer parte da rotina de pré-natal.
- D) Iniciar levotiroxina na dose de 50 mcg/dia.
- E) Solicitar T4 livre e só tratar se estiver abaixo do valor de referência.

7. (Estratégia MED 2025 – Prof. Thiago Barbosa) Uma mulher de 27 anos, portadora de anemia falciforme (HbSS), apresenta-se no pronto-socorro com febre, dor torácica ventilatório-dependente e dispneia progressiva. Relata início dos sintomas há três dias, após um episódio de infecção de vias aéreas superiores. O exame físico revela taquipneia, estertores crepitantes na base direita e saturação de oxigênio de 86% em ar ambiente. A radiografia de tórax evidencia opacidade em lobo inferior direito. Laboratorialmente: Hb = 6,8 g/dL (redução de 3 g/dL em relação à basal), leucocitose neutrofílica e elevação de proteína C reativa. Com base no quadro, qual das condutas abaixo seria INADEQUADA?

- A) Iniciar antibioticoterapia de amplo espectro com cobertura para germes típicos e atípicos.
- B) Iniciar oxigenoterapia suplementar.
- C) Indicar transfusão de concentrado de hemácias para melhorar a oxigenação tecidual.
- D) Priorizar anticoagulação plena para prevenção de tromboembolismo pulmonar.
- E) Manter vigilância em UTI para necessidade de suporte ventilatório.

8. (Estratégia MED 2025 – Prof. Sérgio Beduschi Filho) Homem de 56 anos, previamente hígido, relata quadro de febre, mialgia intensa e poliartralgia que teve início há cerca de 2 meses, quando o diagnóstico de febre Chikungunya foi confirmado por sorologia IgM positiva.

A febre cessou espontaneamente em poucos dias, mas o paciente evoluiu com persistência de dor articular intensa, principalmente em punhos e tornozelos, além de rigidez matinal prolongada, que limita suas atividades diárias. Nega sinais de infecção ativa no momento.

Na consulta atual na unidade básica de saúde, o exame físico mostra dor à palpação e discreto edema em punhos, sem sinais flogísticos exuberantes. Diante do quadro clínico e do tempo de evolução, qual é a conduta terapêutica mais adequada neste momento?

- A) Iniciar antibiótico por suspeita de artrite séptica subaguda.
- B) Solicitar novo exame de sorologia (IgG) para Chikungunya e aguardar resultado antes de tratar.
- C) Iniciar analgesia com dipirona.
- D) Iniciar tratamento com hidroxiquina.
- E) Encaminhar imediatamente para reumatologia por suspeita de artrite reumatoide, sem iniciar nenhum tratamento.

9. (Estratégia MED 2025 – Prof. Bruno Souza) Paciente do sexo masculino, 19 anos, refere aparecimento de manchas hipocrômicas em tronco, principalmente após exposição solar. As lesões são discretamente escamosas, em prurido. Ao estiramento da pele, nota-se descamação fina.

Qual é o agente causador e o tratamento indicado?

- A) *Candida albicans*.
- B) *Malassezia furfur*.
- C) *Trichophyton rubrum*.
- D) *Staphylococcus aureus*.
- E) *Mycobacterium leprae*.

10. (Estratégia MED 2025 – Prof. Thales Thaumaturgo)

Paciente de 45 anos comparece à UBS no início da tarde em consulta de acolhimento devido uma queixa de cefaleia. Ao entrar na sala de triagem, a médica nota prontamente o cheiro de cigarro que acompanha o paciente e aproveita sua ida à unidade para uma sondagem sobre sua motivação em parar de fumar. O homem conta que é tabagista desde os 20 anos de idade, fuma 1 carteira por dia de “cigarro *light*” e já tentou abandonar o vício algumas vezes nos últimos 2 ou 3 anos, mas, atualmente, sente-se bem com seu hábito, pois considera que “ainda é muito novo para ter qualquer problema”. Ele demonstra inclusive desconfiar das informações médicas relacionadas aos inúmeros malefícios causados pelo tabagismo. A profissional, insistente, busca uma explicação mais aprofundada sobre a compreensão do paciente em relação ao tabagismo, mas, subitamente, é interrompida por ele, dizendo de forma ríspida que “fumar é problema dele” e que não estava ali para ouvir sermão.

De acordo com a escala motivacional de Prochaska e DiClemente, o paciente encontra-se na fase de:

- A) Ação.
- B) Contemplação.
- C) Preparação.
- D) Pré-contemplação.
- E) Recaída.

CIRURGIA GERAL

11. (Estratégia MED 2025 – Prof.^a Renatha Paiva) Criança com 6 anos de idade, peso de 16 kg, vítima de atropelamento por motocicleta, é admitido na emergência em prancha rígida e com colar cervical. Ao exame físico, apresenta MV presente bilateralmente, sem ruídos adventícios, FC de 130 bpm, pressão arterial 90 x 50 mmHg; saturação de O₂ de 95%, Glasgow de 07, anisocoria, abdome com escoriações no flanco esquerdo, deformidade do antebraço esquerdo, hematoma subgaleal frontal esquerdo. Com relação ao caso clínico apresentado, a conduta prioritária é:

- A) Imobilizar o antebraço esquerdo.
- B) Tomografia de crânio.
- C) Reposição volêmica com solução cristaloide 20 mL/kg em acesso venoso periférico.
- D) Pré-oxigenação seguida de intubação orotraqueal utilizando tubo com cuff, sob sedação com etomidato (0,1 mg/kg) e paralisação com succinilcolina (1mg/kg).
- E) EIntubação orotraqueal utilizando tubo sem cuff, sob sedação com etomidato (0,3 mg/kg) e paralisação com succinilcolina (2 mg/kg).

12. (Estratégia MED 2025 – Prof.^a Renatha Paiva) Paciente de 35 anos, gestante de 34 semanas, admitida no pronto-socorro com queixa de dor abdominal, inicialmente em região mesogástrica que se irradiou para o flanco direito há 2 dias, associada a náuseas e vômitos desde o início do quadro. Ao exame: regular estado geral, corada, hidratada, febril, eupneica. PA: 110 x 70 mmHg, FC: 82 bpm, FR: 20 irpm. Abdome globoso, gravídico, doloroso em flanco direito, sem sinais de peritonite. Exames laboratoriais: Hb: 11,0 g/dL; Leuco: 17,50 mil/mm³ (3% de bastões); PCR: 42 mg/dL; Creatinina: 1,01 mg/dl; Ureia: 30 mg/dl. Realizada ultrassonografia de abdome que não visualizou o apêndice cecal, ausência de líquido livre na pelve e útero gravídico com feto vivo único.

Em relação ao caso, qual é a principal hipótese diagnóstica e a conduta?

- A) Linfadenite mesentérica / tratamento clínico com sintomáticos.
- B) Apendicite aguda / tratamento cirúrgico por laparoscopia.
- C) Apendicite aguda / solicitar ressonância magnética do abdome.
- D) Apendicite aguda / tratamento clínico com antibioticoterapia e sintomáticos.
- E) Diverticulite aguda de cólon direito / tomografia de abdome.

13. (Estratégia MED 2025 – Prof.^a Renatha Paiva) Paciente masculino, 25 anos, vítima de ferimento por arma de fogo abdominal, deu entrada no pronto-socorro com queixa de dor abdominal. Ao exame: vias aéreas pervias, ausculta cardiopulmonar sem alterações, estável hemodinamicamente, Glasgow 15, abdome doloroso com sinais de irritação peritoneal, orifício de entrada de projétil de arma de fogo no hipocôndrio direito e saída em flanco direito. Submetido à laparotomia exploradora que evidenciou coleperitônio e ferimento transfixante no fundo da vesícula biliar, sem outras lesões. Qual é a conduta nesse caso?

- A) Cirurgia de controle de danos com empacotamento abdominal e peritoneostomia.
- B) Rafia da lesão da vesícula biliar.
- C) Colectomia.
- D) Colectomia e drenagem da via biliar com dreno de Kehr.
- E) Colectostomia pelo ferimento da vesícula biliar.

14. (Estratégia MED 2025 – Prof.^a Renatha Paiva) Paciente feminina, 63 anos, com queixa de dor esporádica em hipocôndrio direito e icterícia notada há 2 semanas. Nega febre. Foi solicitada ultrassonografia de abdome que evidenciou um cisto biliar e ausência de colelitíase. Para uma melhor avaliação do cisto, o cirurgião solicitou uma colangiorressonância que apresentava dilatação fusiforme da via extra-hepática. Em relação a esse caso, podemos afirmar que:

- A) Indica-se ressecção cirúrgica do cisto pelo risco de colangite.
- B) Indica-se ressecção cirúrgica do cisto por ser condição pré-maligna.
- C) Como a paciente está assintomática, podemos observá-la e repetir os exames em 6 meses.
- D) Há indicação de drenagem da via biliar por CPRE para melhora dos sintomas.
- E) A cirurgia de escolha é colectomia e derivação biliodigestiva feita com a parede do cisto e alça de jejuno.

15. (Estratégia MED 2025 – Prof.^a Renatha Paiva) Paciente de 34 anos, vítima de queda do telhado, é atendido no serviço de urgência. À admissão, encontrava-se com vias aéreas pervias, murmúrio vesicular presente bilateralmente, ausência de ruídos adventícios, SatO₂ 96% em ar ambiente, FC: 100 bpm, PA: 110 x 70 mmHg, FR: 20 irpm. Glasgow 15. Abdome flácido, doloroso à palpação profunda em hipocôndrio direito, sem sinais de peritonite. Submetido à tomografia de abdome que demonstrou hematoma hepático intraparenquimatoso de 8 cm de diâmetro, com blush na fase arterial.

Em relação ao caso, qual é a melhor conduta?

- A) Laparoscopia diagnóstica.
- B) Laparotomia exploradora e tratamento definitivo da lesão hepática.
- C) Tratamento não operatório com monitorização contínua em UTI e controle hematócrito.
- D) Tratamento não operatório com monitorização contínua em UTI, controle hematócrito e angioembolização hepática.
- E) Laparotomia exploradora para controle de danos (empacotamento hepático).

16. (Estratégia MED 2025 – Prof. Antonio Rivas) Homem de 35 anos foi vítima de acidente automóvel contra anteparo fixo, sem cinto de segurança há um dia. Procura o pronto atendimento por meios próprios em decorrência de dor torácica que piora ao respirar fundo e ao tossir. Ao exame físico se encontra em bom estado geral, com FC 94; PA 130x70 mmHg; saturando 96% em ar ambiente apresentando estigmas de trauma torácico como equimoses e crepitação na altura do 7º e 8º arcos costais à direita à ausculta pulmonar há redução do MV em terço inferior do hemitórax direito. O paciente foi submetido à radiografia que mostra fratura de 6º, 7º, e 8º arcos costais e pontos únicos, além de velamento completo de cerca de 25% da cavidade pleural, em posição ortostática. Considerando o caso acima, qual a melhor conduta?

- A) Analgesia, orientação acerca de fisioterapia respiratória e alta.
- B) Drenagem torácica com dreno tipo pig-tail.
- C) Drenagem torácica tubular em selo d'água.
- D) Observação por 48 horas, sob oxigenoterapia e analgesia ou bloqueio intercostal.
- E) Toracoscopia e fixação dos arcos costais.

17. (Estratégia MED 2025 – Cirurgia – Prof. Antonio Rivas) Homem de 29 anos chega ao pronto-socorro referindo intensa dor cervical e dificuldade respiratória após agressão com instrumento perfurocortante durante tentativa de assalto. Apresenta-se consciente, com voz rouca e estridor inspiratório. Ao exame físico, observa-se ferida cortocontusa de aproximadamente 5 cm na face anterolateral do pescoço, à direita, entre a cartilagem cricoide e o ângulo da mandíbula, com exteriorização de ar. Saturação em ar ambiente: 89%, FC: 115 bpm, PA: 110x74 mmHg. Glasgow: 14. Ausculta pulmonar normal; exame abdominal e de membros sem alterações. Considerando a localização do ferimento e os achados clínicos, qual é a melhor conduta definitiva após medidas iniciais do protocolo de trauma?

- A) Cervicotomia exploradora.
- B) Tomografia computadorizada cervical com contraste.
- C) Esofagograma com contraste baritado.
- D) Endoscopia digestiva alta à beira-leito.
- E) Angiorressonância magnética da região cervical.

18. (Estratégia MED 2025 – Cirurgia – Prof. Antonio Rivas) Durante a consulta pré-anestésica prévia a uma herniorrafia incisional eletiva, o paciente foi orientado a seguir as recomendações atualizadas de jejum pré-operatório como parte de um protocolo perioperatório de recuperação acelerada. Considerando a preparação para o procedimento, qual das opções abaixo está corretamente associada ao intervalo mínimo recomendado de ingestão antes do início da cirurgia?

- A) Café com leite e torradas — 4 horas.
- B) Bebidas contendo maltodextrina, chá ou água — 2 horas.
- C) Ingestão de balas duras ou pirulitos sem recheio — 2 horas.
- D) Suplemento alimentar à base de caseína — 4 horas.
- E) Refeição completa — 12 horas.

19. (Estratégia MED 2025 – Prof. Antonio Rivas) Um homem de 83 anos é encaminhado à emergência por familiares com queixa de dor abdominal no hipocôndrio direito, febre (38,7 °C) e confusão mental iniciada nas últimas horas. Ao exame físico, encontra-se desorientado, hipotenso (PA 85x55 mmHg) e taquicárdico (FC 115 bpm). Exames laboratoriais revelam: leucopenia, ureia 60 mg/dL, creatinina 3 mg/dL, TGO 80 UI/mL, TGP 95 UI/mL, fosfatase alcalina 340 UI/mL, GGT 500 UI/mL, amilase 50 UI/mL, lipase 40 UI/mL, PCR 40 mg/dL. Ultrassonografia abdominal: vesícula biliar com cálculos, sem imagem de cálculo impactado no infundíbulo e colédoco medindo 1,1 cm. Com base nos dados acima, qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Pielonefrite aguda.
- B) Síndrome de Mirizzi.
- C) Pancreatite aguda.
- D) Colecistite aguda.
- E) Colangite aguda.

20. (Estratégia MED 2025 – Prof. Antonio Rivas) Paciente de 12 anos, sexo masculino, com 50 kg, deu entrada no pronto-socorro após queimadura elétrica sofrida enquanto soltava pipa próxima a uma subestação. O acidente ocorreu há cerca de uma hora. O paciente foi trazido pelo SAMU, que administrou 500 mL de ringer lactato durante o transporte. Ao exame físico, apresenta lesões térmicas de espessura total e parcial profunda em aproximadamente 25% da superfície corporal, incluindo áreas do abdome, tórax anterior e ambos os membros superiores. Considerando o protocolo de reposição volêmica nas primeiras 24 horas, qual é o volume que deve ser administrado e sua distribuição ao longo das próximas horas?

- A) 2500 mL de cristalóide aquecido nas próximas 8 horas e 2500 mL nas 16 horas seguintes.
- B) 3000 mL de cristalóide aquecido divididos igualmente ao longo das próximas 24 horas.
- C) 2000 mL nas próximas 7 horas e 2500 mL nas 16 horas seguintes.
- D) 2000 mL de cristalóide aquecido nas próximas 7 horas e 3000 mL nas 16 horas seguintes.
- E) 2500 mL nas próximas 7 horas e 2000 mL nas 16 horas seguintes.

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

21. (Estratégia MED 2025 – Prof. Alexandre Melitto) Uma adolescente de 14 anos de idade procura o ginecologista referindo que está preocupada porque ainda não menstruou. Ela refere que a sua mãe teve a menarca com 13 anos de idade. Ao exame físico, pode-se observar desenvolvimento das mamas (M3) e pubarca (P3).

Considerando o caso acima, assinale a alternativa correta.

- A) A paciente apresenta quadro de amenorreia primária, porque não apresenta caracteres sexuais secundários.
- B) A paciente apresenta quadro de amenorreia secundária, porque apresenta caracteres sexuais secundários.
- C) A paciente não apresenta quadro de amenorreia, já que apresenta caracteres sexuais secundários.
- D) A paciente apresenta quadro de amenorreia primária, porque a sua mãe menstruou com 13 anos de idade.
- E) A paciente apresenta quadro de amenorreia secundária, porque os seus caracteres sexuais secundários não estão completamente desenvolvidos (M4 e P4).

22. (Estratégia MED 2025 – Prof. Alexandre Melitto) Uma mulher com 36 anos de idade, IGIP (N), tabagista (1 maço por dia). Refere que está usando atualmente a camisinha como método anticoncepcional. Procura a UBS solicitando aconselhamento quanto ao uso de um outro método anticoncepcional. Levando em consideração os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde (OMS), assinale a alternativa que descreve o método anticoncepcional que pode ser indicado para essa paciente:

- A) Pílula combinada.
- B) Anel vaginal.
- C) Adesivo transdérmico.
- D) SIU levonorgestrel.
- E) Injetável mensal.

23. (Estratégia MED 2025 – Prof. Alexandre Melitto) Uma paciente com 57 anos de idade, casada, G2P2A0, comparece ao ginecologista para consulta de rotina. Ao exame físico ginecológico não foram observadas alterações. Traz resultado de colpocitologia com lesão intraepitelial de alto grau (LIEAG). Foi realizada colposcopia com biópsia com resultado de NIC III.

Considerando o caso acima, assinale a alternativa que descreve a conduta mais indicada para este caso.

- A) Histerectomia total.
- B) Histerectomia subtotal.
- C) Exérese da zona de transformação do tipo 3.
- D) Cauterização.
- E) Repetir a colpocitologia em 6 meses.

24. (Estratégia MED 2025 – Prof. Alexandre Melitto) Uma mulher com 32 anos de idade comparece à UBS referindo dor nas mamas quando está perto de menstruar e que melhora após o período menstrual. Refere que a sua mãe teve câncer de mama aos 55 anos de idade e que “está com muito medo de estar com câncer”. Ao exame físico mamário não foram observados nódulos nem espessamentos. As axilas não apresentavam linfonodomegalias.

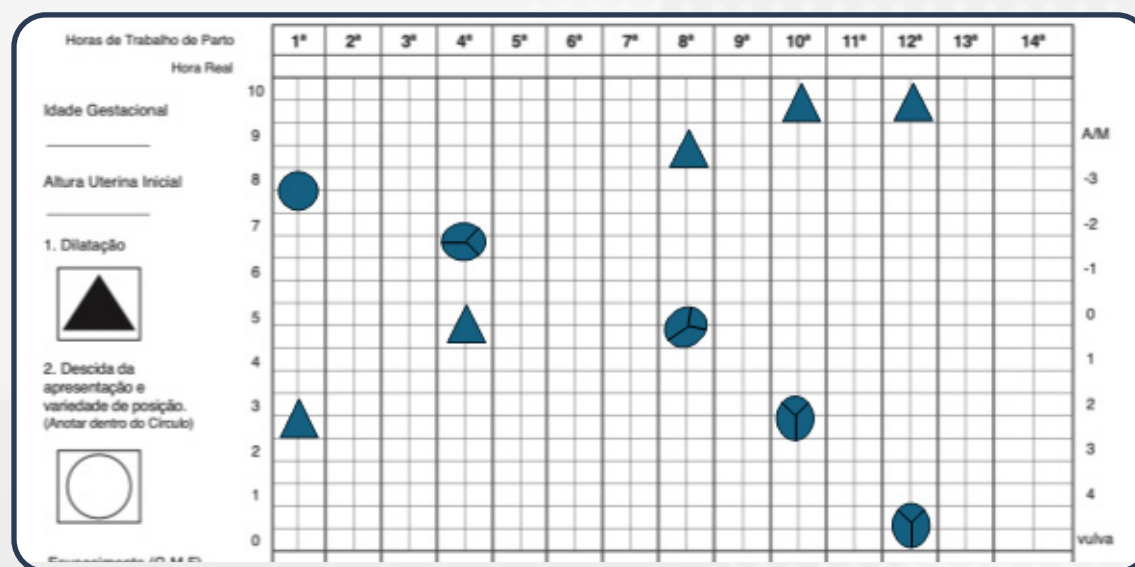
Considerando o caso acima, assinale a conduta inicial indicada para a paciente.

- A) Orientação para afastar a cancerofobia.
- B) Prescrever raloxifeno.
- C) Prescrever letrozol.
- D) Prescrever óleo de primula.
- E) Prescrever vitamina E.

25. (Estratégia MED 2025 – Prof. Alexandre Melitto) Uma mulher de 45 anos de idade comparece à UBS para rotina ginecológica. Deseja fazer mamografia. Refere que a sua cunhada de 53 anos de idade “acabou de descobrir que está com câncer”. Nega antecedentes familiares de neoplasias malignas. Ao exame físico ginecológico não foram encontradas anormalidades. Mamas sem nódulos, axilas livres. A respeito do caso acima, assinale a alternativa correta sobre o rastreamento do câncer de mama, considerando a diretriz do Ministério da Saúde / INCA.

- A) Deve-se solicitar mamografia anual para a paciente a partir dos 40 anos de idade.
- B) Deve-se solicitar mamografia a cada dois anos para a paciente, a partir dos 40 anos de idade.
- C) Deve-se solicitar ultrassonografia anual para a paciente a partir dos 30 anos de idade.
- D) Deve-se solicitar mamografia anual para a paciente a partir dos 50 anos de idade.
- E) Deve-se solicitar mamografia a cada dois anos para a paciente a partir dos 50 anos de idade.

26. (Estratégia MED 2025 – Profª. Natália Carvalho) Primigesta, 40 semanas, vem à maternidade em trabalho de parto. O médico observa que ela está com 4 cm de dilatação, ainda na fase latente do trabalho de parto, mas decide interná-la, pois percebe que a parturiente está muito ansiosa e está com receio de voltar para casa. O acompanhamento do trabalho de parto foi registrado no partograma a seguir.

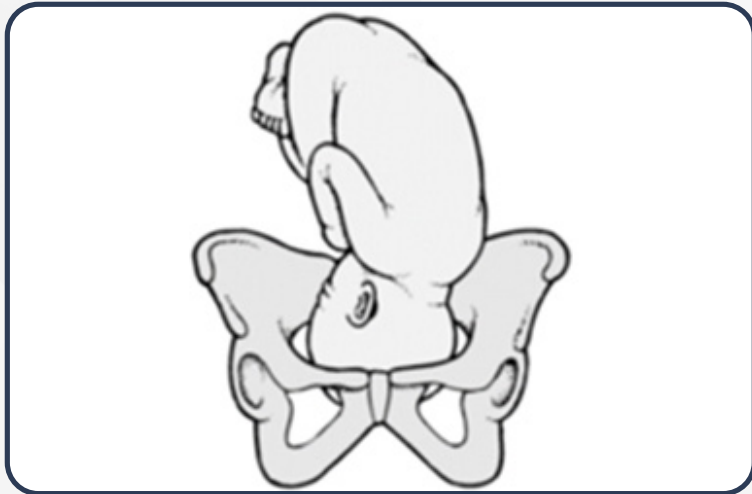


Diante do partograma apresentado, assinale a alternativa que indica o diagnóstico correto.

- A) Distocia de rotação.
- B) Período pélvico prolongado.
- C) Parada secundária da dilatação.
- D) Parada secundária da descida.
- E) Parto eutócico.

27. (Estratégia MED 2025 – Profª. Natália Carvalho)

Parturiente interna na fase ativa do trabalho de parto. Ao realizar as manobras obstétricas e o exame de toque, o obstetra conclui que a estática fetal se encontra conforme a figura a seguir:



Assinale a alternativa que descreve corretamente a estática fetal acima e o mecanismo de parto.

- A) Situação longitudinal, apresentação cefálica, occipito esquerda anterior, rotação interna de 45 graus para occipitopúbica.
- B) Situação transversa, apresentação cefálica, occipito direita anterior, rotação interna de 45 graus para occipitopúbica.
- C) Situação longitudinal, apresentação cefálica, occipito direita anterior, rotação interna de 135 graus occipitopúbica.
- D) Situação transversa, apresentação cefálica, occipito direita anterior, rotação interna de 90 graus para occipitopúbica.
- E) Situação longitudinal, apresentação cefálica, occipito esquerda posterior, rotação de 135 graus para occipitopúbica.

28. (Estratégia MED 2025 – Profª. Natália Carvalho) Primigesta, 25 anos, inicia pré-natal com 18 semanas. Após realizar os exames solicitados na primeira consulta, gestante retorna para checar os resultados, em que consta sorologia para toxoplasmose IgG reagente e IgM reagente. Paciente nega sintomas e nega ter realizado exames anteriormente. Diante do exposto, assinale a alternativa que indica a conduta correta para a gestante.

- A) Solicitar teste de avidéz e prescrever espiramicina
- B) Prescrever espiramicina e repetir sorologia em 3 semanas.
- C) Solicitar amniocentese para pesquisa de infecção fetal e prescrever esquema tríplice.
- D) Prescrever esquema tríplice intercalado com espiramicina a cada 3 semanas
- E) Solicitar ultrassonografia morfológica e, se houver alterações, prescrever esquema tríplice.

29. (Estratégia MED 2025 – Profª. Natália Carvalho) Gestante, 42 anos, parda, 3G2PC, vem a consulta de pré-natal com 11 semanas. Nega comorbidades. Refere descolamento prematuro de placenta na última gestação. Nega queixas atuais. PA 120 x 70 mmHg, IMC 24 kg/m². Diante do exposto, qual é a conduta indicada nesta consulta de pré-natal?

- A) Realizar ultrassonografia transvaginal para avaliar a placenta.
- B) Realizar amniocentese para pesquisa de cromossomopatias.
- C) Realizar teste oral de tolerância a glicose 75g.
- D) Introduzir cálcio e ácido acetilsalicílico.
- E) Introduzir enoxaparina.

30. (Estratégia MED 2025 – Profª. Natália Carvalho) Primigesta, 17 anos, sem comorbidades, vem à primeira consulta de pré-natal com 14 semanas pela data da última menstruação. Tem registradas no prontuário médico vacinas realizadas adequadamente durante a infância, sendo a última vacinação realizada com 10 anos de idade. Diante dos dados fornecidos, assinale a alternativa que apresenta as vacinas indicadas nesta gestação.

- A) Hepatite B, Influenza, Covid-19 e dTpa.
- B) Influenza, Covid-19 e dTpa.
- C) Dengue, Influenza, dT e dTpa.
- D) dTPa, dT, Hepatite B e Covid-19.
- E) dT, Influenza, Covid-19 e Dengue.

PEDIATRIA

31. (Estratégia MED 2025 – Prof. Bruno Calvo) Pedro tem 8 anos e vem apresentando ao longo das últimas 5 semanas um quadro de tosse seca persistente, febre vespertina e perda involuntária de peso. Buscou atendimento em UBS acompanhado pela mãe, que iniciou tratamento para tuberculose pulmonar há 10 dias. Ao exame físico, paciente em bom estado geral, FR 23 irpm, sem sinais de desconforto respiratório, estável hemodinamicamente, ausculta reduzida em base de hemitórax direito e estertores nessa topografia. Em investigação, apresentou radiografia de tórax com consolidação em lobo inferior direito e derrame pleural laminar ipsilateral. Realizou uma prova tuberculínica que resultou em 6 mm. Pesquisa de escarro com TRM-TB e baciloscopia negativas. Qual é a conduta mais adequada para Pedro?

- A) Iniciar tratamento para tuberculose pulmonar com ataque de 2 meses de RIP, e completar com mais 2 meses de RI na fase de manutenção.
- B) Iniciar tratamento para tuberculose pulmonar com ataque de 2 meses de RIP, e completar com mais 4 meses de RI na fase de manutenção.
- C) Não podemos indicar o tratamento contra tuberculose pulmonar sem o diagnóstico microbiológico, e devemos complementar a investigação com pesquisa de *Mycobacterium tuberculosis* em lavado broncoalveolar.
- D) Iniciar tratamento para tuberculose pulmonar com ataque de 2 meses de RIPE, e completar com mais 4 meses de RI na fase de manutenção.
- E) Fazer tratamento empírico para pneumonia bacteriana típica. Caso não haja resposta, considerar iniciar tratamento para tuberculose.

32. (Estratégia MED 2025 – Prof. Bruno Calvo) Adriana tem 7 anos. É trazida à consulta da UBS pela mãe com queixa de surgimento de pilificação em região pubiana há poucas semanas. Além disso, a mãe notou necessidade de uso de desodorantes para evitar odor axilar. Nega outras queixas. Em avaliação, você nota uma criança no estadiamento M1P2 de Tanner, estatura atual no p58 (alvo genético p60), velocidade de crescimento de 7 cm/ano no último ano, genitália típica do sexo feminino de aspecto pré-púbere. Em investigação, você notou que a idade óssea da paciente é de 8 anos e 2 meses. Qual é a principal hipótese diagnóstica e conduta?

- A) Puberdade precoce central. Encaminhar para endocrinologista sugerindo avaliar bloqueio do eixo-HHO.
- B) Puberdade precoce periférica. Investigar tumores produtores de androgênios com TC de abdome e hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, com dosagem de 17-OH-progesterona.
- C) Pubarca precoce isolada. Orientar sobre a benignidade do quadro e manter acompanhamento clínico.
- D) Pubarca precoce isolada. Confirmar o diagnóstico com dosagem de SDHEA e ultrassonografia de adrenal.
- E) Desenvolvimento puberal normal. Manter acompanhamento clínico.

33. (Estratégia MED 2025 – Prof. Bruno Calvo) Regina, paciente de 8 anos, comparece à Unidade Básica de Saúde (UBS) acompanhada de sua genitora, relatando frustração por não conseguir manter o ritmo das aulas de dança devido à sensação de cansaço. A paciente apresenta histórico de crises de tosse seca e dispneia esporádicas desde a infância, contudo, nota um agravamento recente, com episódios ocorrendo quase diariamente, e interrupções noturnas do sono por tais sintomas aproximadamente uma vez por semana. Não faz uso de nenhuma medicação. Diante da principal hipótese diagnóstica, foi solicitada espirometria, a qual revelou distúrbio obstrutivo leve com resposta satisfatória ao broncodilatador e função pulmonar preservada.

Dentre as opções abaixo, qual seria a conduta terapêutica preferencial, em adição às recomendações de higiene ambiental?

- A) Corticoide inalatório em dose baixa diária + SABA se necessário.
- B) Corticoide inalatório em dose baixa somente quando SABA for necessário, antes das aulas de dança.
- C) Uso diário de corticoide inalatório em dose baixa associado a LABA + SABA se necessário.
- D) Uso diário de corticoide inalatório em dose média associado a LABA, para manutenção e resgate.
- E) Uso diário de corticoide inalatório em dose média + LABA se necessário.

34. (Estratégia MED 2025 – Prof. Bruno Calvo) Menina de 6 meses, previamente hígida, comparece à consulta pediátrica de puericultura acompanhada da mãe, que relata amamentação materna exclusiva desde o nascimento. Ela expressa dúvidas e anseios acerca do início da introdução alimentar. O DNPM da criança é adequado para a idade. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, diante desse cenário, a orientação mais apropriada a ser fornecida à mãe é:

- A) Manter aleitamento materno exclusivo.
- B) Inicialmente, sugere-se oferecer suco de frutas previamente ao fornecimento de frutas *in natura*, com o propósito de adaptar o paladar da criança e avaliar a aceitação. Recomenda-se a manutenção do aleitamento materno complementar.
- C) Oferecer comida amassada e manter aleitamento materno complementar. Caso a aceitação da criança seja baixa, considerar adição de sal ou mel como um estímulo ao paladar.
- D) Introduzir uma refeição principal ao longo do dia e uma porção de frutas amassadas, mantendo aleitamento materno complementar.
- E) Iniciar a introdução alimentar com alimentos doces, como bolachas e iogurtes, para facilitar a aceitação nos primeiros meses. Manter aleitamento materno.

35. (Estratégia MED 2025 – Prof. Bruno Calvo) Valentina, 11 anos de idade, comparece ao serviço de saúde queixando-se de dor abdominal, artrite em grandes articulações e surgimento de lesões purpúricas em nádegas e membros inferiores há 4 dias. Também notou que a urina está avermelhada. Os exames de hemograma e coagulograma apresentaram-se sem alterações. Ao exame físico, não foram observadas outras anormalidades além das lesões cutâneas. A paciente relatou histórico de infecção amigdaliana há 17 dias, confirmada por teste rápido para estreptococo em orofaringe, que foi tratada com amoxicilina. Em relação à principal hipótese diagnóstica, é correto afirmar que:

- A) Trata-se de uma farmacodermia leve provocada pela amoxicilina.
- B) Trata-se de uma complicação não supurativa da infecção pelo estreptococo do grupo A. Devemos solicitar um ecocardiograma para investigar a presença de cardite subclínica.
- C) Trata-se de uma complicação não supurativa da infecção pelo estreptococo do grupo A. O consumo do complemento C3 e a presença de hipertensão favorecem esse diagnóstico.
- D) Trata-se de um fenômeno imunológico possivelmente relacionado a infecção pelo estreptococo do grupo A. Deve-se ter atenção ao risco de hemorragias digestivas e disfunção renal.
- E) Trata-se de um fenômeno imunológico possivelmente relacionado a infecção pelo estreptococo do grupo A. Devemos dosar FAN, e investigar a presença de uveíte anterior crônica.

36. (Estratégia MED 2025 – Profª. Helena Schetinger) O teste do olhinho tem fundamental importância no período neonatal e deve ser repetido ao longo dos primeiros anos de vida da criança. Sobre esse teste, é correto afirmar:

- A) O teste só pode ser considerado alterado quando o reflexo é branco bilateralmente.
- B) Com exceção do período neonatal, deve ser realizado apenas pelo oftalmologista.
- C) Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a periodicidade deve ser de duas a três vezes por ano nas consultas de rotina da criança.
- D) Deve ser realizado com a ajuda de um colírio midriático.
- E) Ele tria para doenças oculares, como retinoblastoma, catarata e erros de refração.

37. (Estratégia MED 2025 – Profª. Helena Schetinger) Cinco crianças estão aguardando na Unidade de Saúde para aplicar a vacina contra influenza. Qual delas não poderá ser imunizada nesse momento?

- A) Criança A, 5 meses de idade, apresenta coriza e tosse de início há 24 horas, mas sem febre.
- B) Criança B, 8 meses de idade, em investigação para imunodeficiência primária.
- C) Criança C, 1 ano de idade, em uso de prednisona 3mg/kg/dia, há 30 dias, para doença autoimune.
- D) Criança D, 7 meses, filha de mãe HIV positivo, assintomática no momento.
- E) Criança E, 9 meses de idade, aplicou vacina contra febre amarela no dia de hoje.

38. (Estratégia MED 2025 – Profª. Helena Schetinger) Uma mãe chega no pronto atendimento infantil com seu bebê de 2 meses referindo que o menor “ficou molinho e não respondia ao chamado” há, aproximadamente, 20 minutos. Ao examinar, ele já está assintomático. A mãe diz que aplicou as vacinas da idade ontem a tarde. Considerando o quadro, qual o principal componente vacinal associado a ele e qual orientação deve ser dada a essa mãe com relação a vacinação subsequente?

- A) Pertussis de células inteiras. Aplicar a vacina DTPa em doses subsequentes.
- B) Hepatite B. Aplicar a vacina tetravalente bacteriana em doses subsequentes.
- C) Pneumocócica 10-valente. Dar preferência a pneumocócica 13-valente.
- D) Pertussis acelular. Utilizar a vacina DT aos 4 meses de idade.
- E) Haemophilus influenzae B. Realizar a dessensibilização antes da próxima dose.

39. (Estratégia MED 2025 – Prof^a. Helena Schetinger) Uma menina nasceu de 34 semanas de idade gestacional e 1500g. Ao exame físico, o pediatra percebe que ela apresenta icterícia precoce e hepatoesplenomegalia. Ao realizar uma tomografia de crânio, o laudo apresenta calcificações intracranianas periventriculares. A mãe não fez pré-natal. Qual é a infecção congênita mais provável associada ao caso?

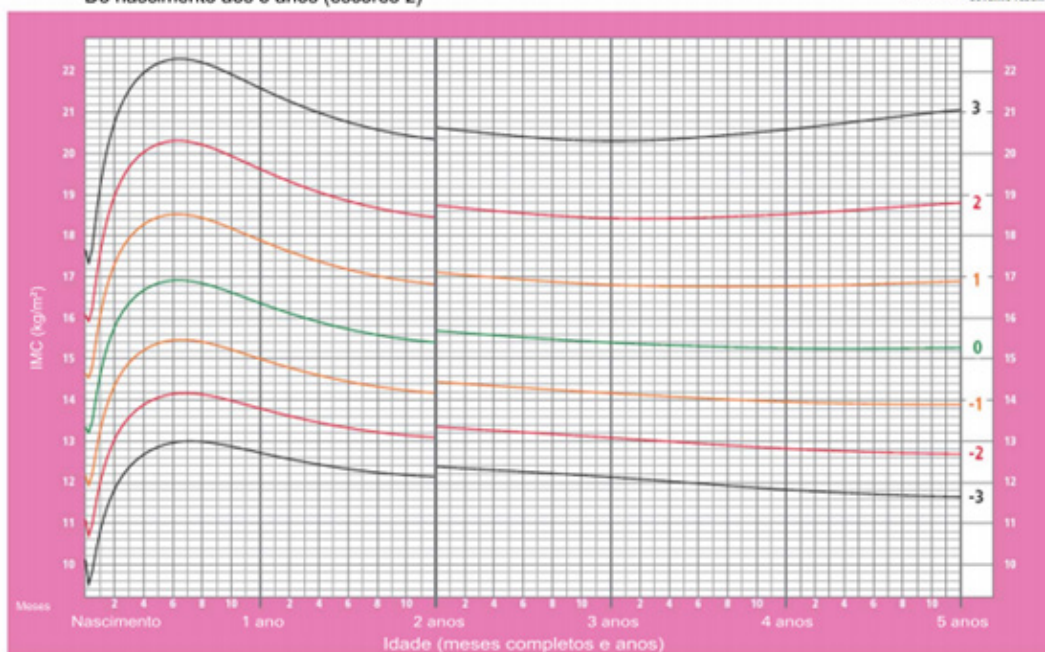
- A) Toxoplasmose congênita.
- B) Sífilis congênita.
- C) Citomegalovirose congênita.
- D) HIV congênito.
- E) Rubéola congênita.

40. (Estratégia MED 2025 – Prof^a. Helena Schetinger) Uma menina de 4 anos chega para consulta na pediatria da UBS, pois a mãe acredita que ela está muito “gordinha”. Seus hábitos alimentares incluem salgadinhos e bebidas açucaradas e não gosta de verduras, legumes e frutas. Não pratica exercícios físicos e passa a maior parte do dia jogando no tablet. Seu exame físico é normal e os dados antropométricos obtidos da consulta revelam peso de 26 Kg e estatura de 110cm. De acordo com os dados fornecidos e utilizando o gráfico abaixo, indique o diagnóstico nutricional da criança em relação ao IMC:

IMC por Idade MENINAS

Do nascimento aos 5 anos (escores-z)

Ministério da Saúde
BRS
GOVERNO FEDERAL

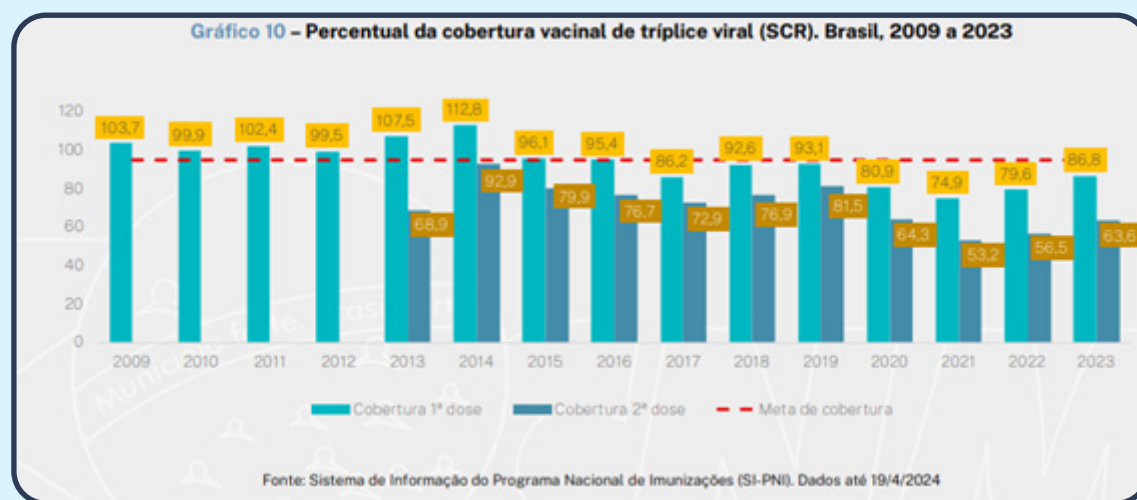


Fonte: WHO Child Growth Standards, 2006 (<http://www.who.int/childgrowth/en/>)

- A) Eutrófica.
- B) Obesidade.
- C) Obesidade grave.
- D) Risco de sobrepeso.
- E) Sobrepeso.

MEDICINA PREVENTIVA

41. (Estratégia MED 2025 – Prof^a. Laís Parada) O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, cuja prevenção se dá principalmente pela vacinação com a tríplice viral. É uma doença grave que pode levar a complicações sérias, incluindo pneumonia, encefalite e, em casos raros, morte, especialmente em crianças. A doença é altamente contagiosa, transmitida por contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Olhe o gráfico a seguir retirado da avaliação de cobertura vacinal em crianças de até 5 anos, retirado do material realizado pela Confederação Nacional de Municípios.



Fonte: https://cnm.org.br/storage/biblioteca/2024/Estudos_tecnicos/202407_ET_SAU_Avaliacao_coberturas_vacinais_municipios_crianças_cinco_anos.pdf

Considerando as informações apresentadas e recomendações do Ministério da Saúde, interprete as afirmativas a seguir:

- I. A meta de cobertura para sarampo com a tríplice viral é 90%.
- II. Em 2024, cinco anos após perder o certificado de eliminação do sarampo, em 2019, o Brasil voltou a receber da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) o status de país livre da doença.
- III. O último registro de sarampo no Brasil, sem ser por caso importado de outro país, de acordo com o Ministério da Saúde, aconteceu em junho de 2024.
- IV. Uma das razões para a queda de cobertura vacinal vem do desconhecimento da gravidade da doença, da eficácia da vacina para proteção e baixa taxa de efeitos adversos.

Assinale as alternativas com todas as afirmativas corretas:

- A) I, II e IV.
- B) II e IV.
- C) Todas estão corretas.
- D) Apenas a IV está correta.
- E) II e III.

42. (Estratégia MED 2025 – Profª. Laís Parada) Paciente de 59 anos, morador de região de fronteira entre municípios, apresenta quadro de dor torácica sugestiva de Síndrome Coronariana Aguda. O paciente foi até a Unidade Básica de Saúde do município de fronteira do seu, mas, ao chegar, foi informado que não havia vaga disponível e que deveria procurar atendimento na sua cidade, pois a UBS só poderia atender pacientes do próprio município.

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) aplicáveis a esse caso, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A recusa de atendimento foi justificada, pois a regionalização preconiza que cada município seja responsável apenas por seus munícipes.
- B) O caso exemplifica adequada aplicação da descentralização, em que cada município define critérios próprios de acesso ao seu sistema de saúde.
- C) A hierarquização dos serviços determina que pacientes de outros municípios só podem ser atendidos após autorização formal da secretaria municipal de saúde de origem.
- D) O paciente deveria ser atendido independentemente de seu município de origem, respeitando os princípios da universalidade e integralidade.
- E) O princípio da equidade foi corretamente aplicado, ao priorizar residentes do município onde o serviço está instalado.

43. (Estratégia MED 2025 – Profª. Laís Parada) Às 9h da manhã, médico plantonista em UPA é chamado para constatar óbito de homem de 98 anos encontrado em sua residência pelo filho durante a manhã, que o trouxe imediatamente ao pronto-socorro. Ao exame, identifica ausência de pulso e discreta rigidez do corpo. Segundo familiares, o paciente tinha “problema no coração”, e havia relatado mal-estar leve no dia anterior que não sabiam descrever, no entanto, ele não quis ir ao pronto-socorro. Não há sinais de violência ou circunstâncias suspeitas; família parecia dar um bom suporte ao idoso e estava muito triste. Há Instituto Médico Legal e Serviço de Verificação de Óbito.

Quanto ao preenchimento do atestado de óbito neste caso, é CORRETO afirmar que:

- A) O médico deve se recusar a fornecer o atestado e encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), por tratar-se de morte sem assistência médica.
- B) Na parte I do atestado, deve-se indicar "causa indeterminada" na linha A e deixar as demais linhas em branco, por não haver diagnóstico definitivo.
- C) O médico pode fornecer o atestado, considerando as patologias preexistentes na parte I e indicando "morte natural" na parte II.
- D) O médico deve preencher "morte sem assistência médica" como causa básica e encaminhar uma via do documento à autoridade policial.
- E) O médico não deve fornecer o atestado de óbito, e deve encaminhar o corpo para o Serviço de Verificação de Óbito.

44. (Estratégia MED 2025 – Profª. Laís Parada) Durante plantão em um pronto-socorro, médica atende paciente de 17 anos com intoxicação exógena voluntária por ingestão de medicamentos psiquiátricos. Após estabilização do quadro, o paciente revela à médica que tentou suicídio e solicita expressamente que essa informação não seja compartilhada com seus pais e familiares, que aguardam na sala de espera. Refere que se sente envergonhado e que a família não entenderia sua decisão. A médica observa que o paciente está lúcido, orientado e sem alterações cognitivas no momento, mas identifica sinais de depressão grave e risco de nova tentativa de autoextermínio após a alta.

Considerando o Código de Ética Médica e os aspectos ético-legais relacionados ao sigilo médico em situações de risco de suicídio, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O sigilo médico é absoluto nesse caso, devendo a médica respeitar integralmente a vontade do paciente de não informar aos familiares sobre a tentativa de suicídio, mesmo identificando risco de nova tentativa.
- B) A médica deve comunicar imediatamente às autoridades policiais sobre a tentativa de suicídio, pois trata-se de evento de notificação compulsória que sobrepõe o dever de sigilo.
- C) A quebra do sigilo médico justifica-se nesse caso, pois o risco de nova tentativa de suicídio caracteriza situação de risco à vida do paciente, devendo a médica informar a familiares e solicitar avaliação psiquiátrica.
- D) A médica deve preservar o sigilo e apenas notificar a tentativa de suicídio à vigilância epidemiológica, sem necessidade de comunicação aos familiares, uma vez que o paciente é adulto e se encontra lúcido.
- E) A médica deve condicionar o tratamento à autorização do paciente para revelar a informação aos familiares, caso contrário, não poderá prestar assistência devido à ausência de responsável legal presente.

45. (Estratégia MED 2025 – Profª. Laís Parada) Durante consulta de rotina na Unidade Básica de Saúde, homem de 55 anos, assintomático, sem comorbidades ou histórico familiar relevante, solicita exames de rastreamento para câncer de próstata, incluindo PSA (Antígeno Prostático Específico) e toque retal. Refere que um colega de trabalho foi diagnosticado recentemente com essa neoplasia.

Considerando as recomendações do Ministério da Saúde e os princípios do rastreamento populacional, a conduta mais adequada é:

- A) Solicitar o PSA anualmente e realizar o toque retal, pois o rastreamento universal para câncer de próstata reduz significativamente a mortalidade específica.
- B) Explicar duvidosos benefícios e os potenciais riscos do rastreamento para câncer de próstata, incluindo resultados falso-positivos e sobrediagnóstico, permitindo decisão compartilhada.
- C) Negar a solicitação, pois esses exames para detectar câncer de próstata são contraindicados em qualquer circunstância, pela elevada taxa de complicações do tratamento.
- D) Solicitar apenas o PSA trimestralmente, dispensando o toque retal, por ser procedimento invasivo com baixa aceitabilidade.
- E) Encaminhar diretamente ao urologista, pois a idade acima de 50 anos é critério absoluto para especialização do cuidado em saúde do homem.

46. (Estratégia MED 2025 – Profª. Laís Parada) Médica da Família e Comunidade da Unidade Básica de Saúde recebe resultado de biópsia confirmando diagnóstico de adenocarcinoma pancreático metastático em paciente de 67 anos. A paciente comparece à consulta acompanhada da filha. A filha já viu o resultado do exame e solicita reservadamente que a mãe não seja informada sobre o diagnóstico de câncer, alegando fragilidade emocional e histórico de depressão. Atualmente, a paciente não apresenta sinais de fragilidade ou alteração no exame psíquico.

Considerando os aspectos éticos e o protocolo SPIKES para comunicação de más notícias, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada:

- A) Atender à solicitação da filha, comunicando apenas a ela o diagnóstico e prognóstico, preservando a paciente de sofrimento psicológico adicional.
- B) Informar detalhadamente o diagnóstico, prognóstico e opções terapêuticas à paciente, independentemente do pedido da filha.
- C) Avaliar a capacidade de compreensão e o desejo da paciente em receber informações sobre sua condição, oferecendo-as de forma gradual e adequada às suas necessidades, respeitando sua autonomia.
- D) Utilizar termos técnicos e eufemismos ao comunicar o diagnóstico, evitando mencionar a palavra "câncer" e focando apenas nas possibilidades terapêuticas.
- E) Encaminhar a paciente ao oncologista para comunicação do diagnóstico, eximindo-se da responsabilidade direta pela notificação da má notícia.

47. (Estratégia MED 2025 – Profª. Laís Parada) Em um determinado município, observou-se uma elevada taxa de mortalidade infantil. Análises demonstraram que a maior parte dos óbitos estava relacionada à mortalidade neonatal precoce. Diversas medidas foram implementadas, resultando em uma melhora significativa tanto na mortalidade neonatal precoce quanto na tardia. Atualmente, o componente neonatal representa menos de 10% dos óbitos em crianças menores de 1 ano. Apesar dessa redução expressiva, a mortalidade infantil como um todo permanece elevada.

Considerando esse cenário, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A principal intervenção no cenário atual deve estar voltada à assistência pré-natal na Atenção Primária e ao cuidado no parto.
- B) A principal medida responsável pela redução da mortalidade neonatal deve ter sido a vacinação infantil.
- C) A proporção atual de mortalidade neonatal está dentro das variações esperadas e independe de intervenções específicas.
- D) O componente predominante da mortalidade infantil nesse cenário não é passível de redução por meio de ações do sistema de saúde.
- E) Uma possível intervenção atual deve estar focada na identificação de falhas no cuidado e no acompanhamento da puericultura na Atenção Primária e locais de urgência e emergência que recebem as crianças abaixo de 1 ano.

48. (Estratégia MED 2025 – Profª. Laís Parada) Em estudo sobre novo teste para diagnóstico precoce de tuberculose pulmonar, foram avaliados 500 pacientes sintomáticos respiratórios. Todos realizaram o novo teste e, como padrão-ouro, cultura de escarro. Os resultados estão apresentados na tabela abaixo:

	Cultura Positiva	Cultura Negativa	Total
Novo Teste Positivo	90	60	150
Novo Teste Negativo	10	340	350
Total	100	400	500

A partir desses dados, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a estimação do valor preditivo positivo (VPP) do novo teste e sua interpretação clínica:

- A) VPP = 60%, indicando que 60% dos pacientes com resultado positivo no novo teste realmente têm tuberculose pulmonar, o que sugere moderada utilidade para confirmação diagnóstica.
- B) VPP = 90%, indicando que 90% dos pacientes com tuberculose pulmonar terão resultado positivo no novo teste, o que justifica seu uso como teste de triagem.
- C) Não há como calcular o VPP, pois não há a prevalência da tuberculose.
- D) VPP = 90%, indicando que 90% dos pacientes com tuberculose pulmonar terão resultado positivo no novo teste, o que justifica seu uso como exame confirmatório.
- E) VPP = 60%, indicando que entre todos os pacientes testados, 60% dos pacientes com tuberculose terão o resultado positivo.

49. (Estratégia MED 2025 – Profª. Laís Parada) Médico de família atende gestante de 16 anos, no segundo trimestre de gravidez, que refere não ter realizado nenhuma consulta pré-natal até o momento. Mora em ocupação irregular sem saneamento básico, abandonou a escola no ano anterior, não possui renda própria e relata insegurança alimentar no domicílio. Durante o atendimento, mostra-se ansiosa quanto ao futuro e menciona não ter apoio do pai da criança.

Considerando o modelo de Determinantes Sociais de Saúde adotado pela Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), assinale a alternativa CORRETA:

- A) O principal determinante social no caso é a gravidez na adolescência, sendo os demais apenas fatores secundários nessa condição, exigindo abordagem centrada no planejamento familiar.
- B) A insegurança alimentar representa um determinante social, devendo ser tratada exclusivamente por meio de encaminhamento aos programas de transferência de renda.
- C) O caso exemplifica determinantes sociais de natureza individual e sociais, não havendo influência significativa de fatores estruturais ou políticas públicas em sua condição de saúde.
- D) Para abordagem dos determinantes sociais precisa-se de multidisciplinaridade, em que essa responsabilidade é de assistentes sociais. A abordagem médica deve focar nos aspectos clínicos da gestação, pois os determinantes sociais estão fora do escopo de atuação da equipe de saúde.
- E) Os determinantes sociais presentes nesse caso atuam em diferentes níveis (individual, social e estrutural), interagem entre si e ampliam vulnerabilidades, demandando abordagem intersetorial para promoção da saúde.

50. (Estratégia MED 2025 – Prof^a. Laís Parada) Médica de Família e Comunidade recém-contratada para atuar em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que atende território com presença significativa das comunidades quilombola, LGBT+ e indígenas aldeados, observa a necessidade de capacitação da equipe para melhor atendimento a esses grupos. Durante reunião com a coordenação municipal de saúde, ela sugere a implementação de ações baseadas nas políticas nacionais específicas para essas populações.

Considerando as características específicas das políticas nacionais de saúde voltadas para populações vulnerabilizadas, analise as afirmativas abaixo:

I. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) é operacionalizada por meio dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que possuem delimitação geográfica baseada em critérios epidemiológicos, geográficos e etnográficos, não se limitando às divisões administrativas estaduais e municipais.

II. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) reconhece haver agravos de maior prevalência nesse grupo populacional, recomendando ações específicas de prevenção, diagnóstico e tratamento.

III. A Política Nacional de Saúde Integral LGBT, junto a leis, encoraja os profissionais, respeitando autonomia à opção de utilização do nome social dos usuários nos serviços de saúde, para respeitar a identidade de gênero dos usuários.

IV. As três políticas citadas integram como ação comum o combate ao racismo institucional e outras formas de discriminação, reconhecendo-os como determinantes sociais que afetam diretamente as condições de saúde dessas populações.

V. A implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra ocorre principalmente por meio da criação de serviços exclusivos para essa população, com unidades de saúde específicas para atendimento especializado em áreas periféricas e comunidades quilombolas.

Assinale a alternativa que contém apenas afirmativas CORRETAS:

- A) I, II e IV.
- B) I, III e IV.
- C) II, III e IV.
- D) I, II e V.
- E) III, IV e V.



PREENCHA SEU GABARITO



Estratégia MED



@estrategiamed



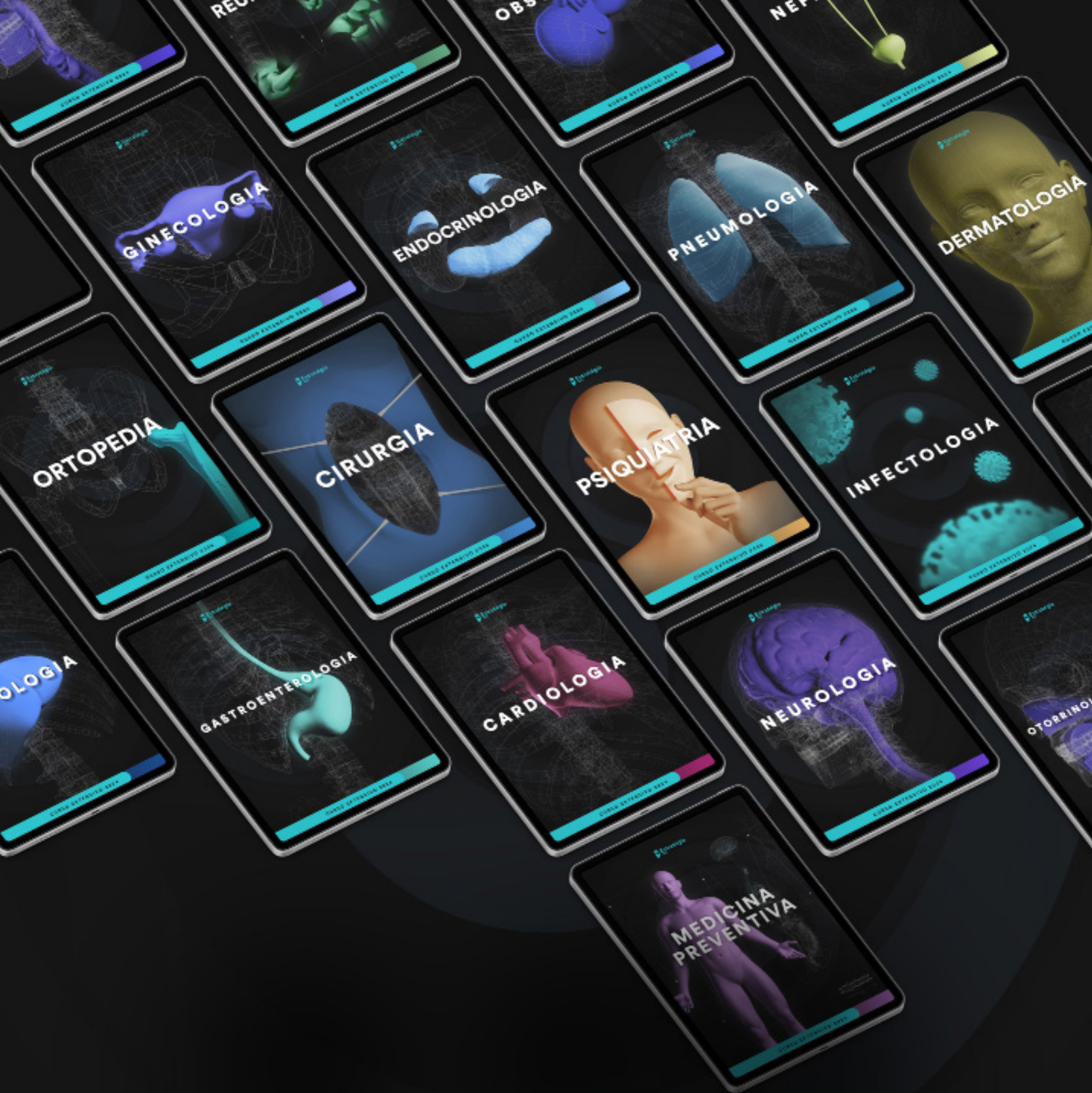
@estrategiamed



t.me/estrategiamed



/estrategiamed



med.estrategia.com